

Percorsi nelle Disabilità — Panoramica completa

Semestre 02 · 9 lezioni elaborate (01, 02, 04–10; mancano 03 e 11)

Da Hammurabi alle politiche inclusive ticinesi del 2024, questo modulo costruisce uno sguardo completo sulla disabilità: prima la storia e le classificazioni, poi i quadri legali e i modelli interpretativi, infine le situazioni specifiche (deficit intellettivo, ASD, polyhandicap) e la progettualità di vita. Il filo rosso è sempre lo stesso: la disabilità non è nella persona — è nell'interazione tra la persona e un contesto più o meno ostile.

Mappa dei temi

#	Lezione	Tema centrale
01	Presentazione del modulo	Struttura del corso, Gardou, inclusione vs. integrazione
02	Disabilità nella storia — Parte 1	Dall'antichità ai pionieri dell'educazione speciale
03	Disabilità nella storia — Parte 2	<i>(non ancora elaborata)</i>
04	Convenzione ONU sui diritti (CDPD)	Quadro legale internazionale, Lingua Facile
05	Cambiamento dei concetti e modelli	ICD, ICIDH, ICF, PPH, 4 modelli istituzionali
06	ICF	Struttura dettagliata, codifica, facilitatori e barriere

#	Lezione	Tema centrale
07	Deficit Intellettivo	Criteri AAIDD, QI, comportamento adattivo, sostegni
08	ASD — Parte 1	Storia, diade diagnostica DSM-5, neurodiversità
09	ASD — Parte 2 e Polyhandicap	Intervento educativo, CAA, approcci; polyhandicap
10	Qualità di vita e progettualità	Meta-modello QdV, progetto di vita, assessment

Evoluzione storica del concetto di disabilità

- **Antichità** → deficit = punizione divina o problema di sopravvivenza del gruppo
 - Infanticidio/esposizione accettati legalmente (Grecia, Roma)
 - **Ius vivendi** (Costantino, 274–337) → primo riconoscimento del diritto alla vita · (Lez. 02)
- **Mesopotamia** → modello magico; prima classificazione (mostri per eccesso/difetto/doppi, tavoletta 2800 a.C.) · (Lez. 02)
- **Medioevo** → "follia" come contenitore indifferenziato; visione dualistica Dio/Satana
 - **Grande Reclusione** → ospedali generali → segregazione ma anche prime risposte educative · (Lez. 02)
- **Fine '700 — Illuminismo** → Rivoluzione Francese → diritti dell'uomo → nasce la pedagogia speciale
 - **Pinel (1793)** → trattamento morale; toglie le catene agli alienati a Bicêtre
 - **Épée (1760)** → prima scuola pubblica per sordi
 - **Haüy (1784)** → prima scuola per ciechi; forma Louis Braille
 - **Esquirol (1818)** → prima distinzione scientifica disagio psichico ≠ deficit intellettivo

- **Itard (1800–1801)** → 5 principi pedagogici (Victor dell'Aveyron) → "tutte le persone sono educabili"
- **Séguin (1837)** → prima scuola per persone con deficit intellettivo · (Lez. 02)
- **Anni '70** → movimenti attivisti USA → prime norme antidiscriminazione; nascita associazioni (Atgabbes 1967, Fondazione Diamante 1978, LISPI 1979) · (Lez. 04)
- **Evoluzione terminologica** · (Lez. 05):

Periodo	Termine	Modello
Fine anni '70	Invalido	Riabilitazione
Fine anni '80	Handicappato	Integrazione
Fine anni '90	Persona disabile	Partecipazione
Dal 2000	Persona con disabilità	Inclusione come diritto

Modelli interpretativi della disabilità

- **Modello biomedico** → deficit individuale; riparare la persona
- **Modello funzionale/riabilitativo** → recupero delle capacità operative
- **Modello ambientale** → le barriere del contesto creano l'handicap
- **Modello civico / diritti umani** → esclusione = discriminazione; il sistema deve cambiare
- **Modello biopsicosociale (ICF/CDPD)** → disabilità = interazione persona ↔ ambiente · (Lez. 05, 06)

4 modelli istituzionali (Mainardi, 2010) · (Lez. 05)

Quadrante	Luogo	Attenzione	Nome
0	Speciale	Nessuna	Esclusione / Ghettizzazione
1	Speciale	Speciale	Segregazione
2	Ordinario	Speciale (eccezionale)	Integrazione

Quadrante	Luogo	Attenzione	Nome
3	Ordinario	Normalmente speciale	Inclusione

- **Integrazione** → misura eccezionale per la persona specifica; la persona si adatta al sistema · (Lez. 01, 05)
- **Inclusione** → misure speciali normali a priori per tutti; il sistema si adatta · (Lez. 01, 05)
 - ⚠ Rischi: banalizzazione del termine, inclusione senza risorse = ri-esclusione mascherata
 - È una direzione, non un traguardo raggiunto
 - ⚠ In certi momenti la separazione è la risposta migliore alla qualità di vita della persona

Classificazioni e strumenti OMS

- **ICD** → classifica le malattie per eziologia/patologia/manifestazione clinica; modello medico · (Lez. 05)
- **ICIDH (1980)** → malattia → menomazione → disabilità → handicap
 - Critica: lineare, negativo, non considera abbastanza l'ambiente, non dinamico · (Lez. 05)
- **PPH** → handicap come risultato di interazione persona-ambiente (innovazione rispetto a ICIDH) · (Lez. 05)
- **ICF (OMS, 2001)** → classificazione attuale; modello biopsicosociale · (Lez. 05, 06)

ICF

└─	Parte 1: FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ
	└─ Funzioni corporee (8 domini – b)
	└─ Strutture corporee (8 domini – s)
	└─ Attività e Partecipazione (9 domini – d)
└─	Parte 2: FATTORI CONTESTUALI

└─ Fattori ambientali (5 domini – e)

└─ Fattori personali (non classificati)

- **Capacità** → cosa la persona può fare in ambiente standard (caratteristica intrinseca)
- **Performance** → cosa la persona fa nel suo contesto reale (dipende dal contesto)
- **Facilitatore** (+) → fattore ambientale che migliora il funzionamento
- **Barriera** (.) → fattore ambientale che limita il funzionamento e amplifica la disabilità
- **ICF-CY (2007)** → versione per 0–18 anni
- Distinzioni qualificative: **menomazione** (disfunzione corporea) · **limitazione** (difficoltà nell'attività) · **restrizione** (problema nella partecipazione) · (Lez. 06)

Quadro legale e diritti

- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948)** → radice di tutte le convenzioni · (Lez. 04)
- **CDPD – Convenzione ONU** (adottata 13.12.2006; in vigore 2008; ratifica CH 15.04.2014) · (Lez. 04)
 - **Slogan** → "Niente su di noi, senza di noi"
 - **50 articoli**; non introduce nuovi diritti, concretizza quelli universali per le persone con disabilità
 - Disabilità = interazione tra menomazioni e **barriere ambientali/comportamentali** (Preambolo, art. e)

Articolo	Tema
Art. 19	Vita indipendente e scelta del luogo di vita
Art. 21	Accesso all'informazione nella forma comunicativa scelta
Art. 24	Educazione inclusiva a tutti i livelli
Art. 27	Lavoro inclusivo e non discriminatorio

Articolo	Tema
Art. 29	Vita politica e autodeterminazione

- Svizzera **non ha aderito** al Protocollo Facoltativo → nessun ricorso individuale al Comitato ONU
- Valutazione ONU Svizzera → esito negativo su istruzione, lavoro, scelta residenza
- **Iniziativa per l'Inclusione** → 107.910 firme, settembre 2024 · (Lez. 04)

Lingua Facile · (Lez. 04, 05)

- Basi CDPD: Art. 9 (accessibilità) + Art. 21 (libertà di espressione e accesso all'informazione)
- In Svizzera: Pro Infirmis; Ticino: Fondazione Diamante; Canton TI (votazioni dal 2019), RSI (2025)
- Quadro TI: Mozione 1446 (2019), Art. 13a Cost. TI (2022)
- **Integrativa** se disponibile solo su richiesta | **Inclusiva** se adottata a priori per tutta la comunicazione pubblica · (Lez. 05)

Deficit Intellettivo (DI)

- **Definizione AAIDD (2022)** → limitazioni significative in funzionamento intellettuale + comportamento adattivo, con esordio prima dei 22 anni · (Lez. 07)
- **3 criteri diagnostici** (tutti e tre devono coesistere):
 - **A. Funzionamento intellettuale** → $QI < 70$ (≥ 2 DS sotto la media; test Wechsler, Stanford-Binet)
 - **B. Comportamento adattivo** → ≥ 2 DS sotto la media in almeno 1 dei 3 domini (concettuale, sociale, pratico)
 - **C. Età di esordio** → prima dei 22 anni

- **Terminologia** → "deficit intellettivo" (corretto); "ritardo mentale" (obsoleto, da non usare)
 - **Disabilità cognitiva** = cappello più ampio (include DI + DSA + ADHD + difficoltà percettive)
- **Prevalenza** → 1–1,5% della popolazione (DSM-5)
- **Eziologia** → 30–40% sconosciuta; cause note: alterazioni embrionali (30%), fattori perinatali (10%), ereditari (5%)
- **Classificazione** → per intensità del sostegno (più utile del solo QI):

Livello	QI indicativo	Sostegni
Gravissimo	0–20/25	Continuo
Grave	20/25–40/45	Estensivo
Medio-grave	40/45–55	Limitato
Lieve	55–70/75	Intermittente

- **Sistemi di sostegno efficaci (AAIDD)** → centrati sulla persona · completi · coordinati · orientati agli esiti · (Lez. 07)
 - **Sostegni naturali** → famiglia, amici, comunità, tecnologia assistiva
 - **Sostegni specialistici** → operatori sociali, terapisti, didattica speciale
 - **Scaffolding** (Wood, Bruner, Ross, 1976) → impalcatura di supporto che si toglie con la crescita
 - **ZSP (Vygotskij)** → calibrare i sostegni vicino ai bisogni attuali; aggiornare con l'evoluzione
 - **SIS** (Thompson et al., 2004) → strumento per misurare l'intensità dei sostegni necessari
-

Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

- **Definizione** → sindrome comportamentale da disordine del neurosviluppo biologicamente determinato; diagnosi comportamentale; esordio prima dei 3 anni · (Lez. 08)
- **Frase-chiave** → "L'autismo non si cura, si **educa**"
- **Prevalenza** → 1/36 USA · 1/77 Italia · ~80.000 CH; 4× più frequente nei maschi

Tappe storiche chiave · (Lez. 08)

- **Kanner (1943)** → "autismo precoce infantile" — 11 bambini; ipotesi innata
- **Bettelheim (anni '60)** → "madre frigorifero" → errore storico; le cause non sono psicogene
- **Wing (1983)** → triade + concetto di **spettro**
- **DSM-5 (2013)** → unica etichetta ASD + **diade diagnostica** + 3 livelli di gravità

Diade diagnostica DSM-5 · (Lez. 08)

- **A** → deficit comunicazione e interazione sociale:
 - A.1 deficit reciprocità socio-emotiva
 - A.2 deficit comportamenti comunicativi non verbali
 - A.3 deficit sviluppo e gestione relazioni
- **B** → pattern ristretti e ripetitivi:
 - B.1 stereotipie, ecolalia
 - B.2 insistenza nella sameness (routine rigide)
 - B.3 interessi ristretti e fissi
 - B.4 iper- o ipo-reattività sensoriale (SIRS/HYPO/HYPER/EP)
- **3 livelli di gravità** → 1 (supporto) · 2 (supporto sostanziale) · 3 (supporto molto sostanziale)
- **Neurodiversità** (Singer, anni '90) → variazione neurologica come naturale variabilità umana

- Regola: "**Hai visto una persona con ASD — ne hai vista solo una**"

Intervento educativo nell'ASD · (Lez. 09)

- **Analisi funzionale** → non la diagnosi, ma come la persona funziona nel suo contesto
 - Focus su: capacità residue e **potenzialità di sviluppo** (qui si costruiscono gli obiettivi)
- **Aree PEI** → abilità motorie · autonomie personali · apprendimenti scolastici · abilità sociali · comunicazione
- **CAA/PECS** → quando il verbale non è raggiungibile; prerequisiti della comunicazione: percezione, imitazione, attenzione condivisa, intento comunicativo
- Principi chiave: training strutturato e ripetuto da tutti · abbassare l'ansia prima del training · usare la motivazione intrinseca
- **Comportamenti problema** → hanno funzione comunicativa → sostituire, non sopprimere (valutazione funzionale)

Metodo	Autore	Principio
ABA	Skinner	Rinforzo comportamento in setting 1:1
TEACCH	Schopler (1972)	Struttura visiva + adattamento ambientale
ESDM (Denver)	Rogers e Dawson	Parent training + ABA + sviluppo; da 12 mesi
Approcci naturalistici	Koegel et al. (1979)	Iniziativa del bambino in contesti spontanei
CAA / PECS	—	Comunicazione simbolica alternativa
CBT	Ellis e Beck	Pensieri + emozioni + comportamenti

Polyhandicap · (Lez. 09)

- **Definizione** → deficit fisico importante + deficit intellettivo severo/profondo; causa: danno cerebrale grave e precoce (prima dei 3 anni)
 - **Effetto** → restrizione estrema di autonomia, percezione, espressione, relazione; evolve nel tempo
 - **Funzionamento intellettivo** → livello profondo; ≈ bebè 6 mesi; periodo senso-motorio Piaget (stadi 1–4)
 - **Comunicazione** → comprensione precede sempre la produzione
 - ⚠ "non produrre ≠ non capire" — errore grave da non fare mai
 - Canale principale: non verbale (sguardo, gesti minimi); **causalità elementare** come base per comunicare
 - **Salute** → polipatologie gravi evolutive; epilessia frequente; dolore in 4 forme; effetti a cascata dal deficit motorio
 - Cambiamenti di comportamento = possibile segnale di dolore fisico non comunicato
 - **Dimensione etica** → persona non verbale non può segnalare abusi → supervisione d'équipe fondamentale; mai soli con questa utenza
 - **Sostegni** → intensità massima; équipe pluridisciplinare; parent training in tutti i momenti chiave della vita
-

Qualità di Vita e Progettualità · (Lez. 10)

- **Cambio di paradigma** → da sguardo medico (persona = diagnosi; operatore prescrive) a sguardo bio-psico-sociale (operatore accompagna; focus su barriere e sostegni)
 - Base: ICF (OMS) + Convenzione ONU → transizione: cura della persona → cura dei contesti

- **Qualità di vita (OMS, 1995)** → percezione individuale della propria posizione nella vita in relazione a obiettivi, aspettative, standard, interessi; è **soggettiva, multidimensionale, misurabile**

- Doppio ruolo (Cottini, 2016): **macro-finalità** di ogni intervento + **strumento di valutazione**

Meta-modello Schalock e Verdugo (2006) • (Lez. 10)

3 fattori → 8 domini → indicatori

Fattore	Domini
Indipendenza	Sviluppo personale · Autodeterminazione
Partecipazione sociale	Relazioni interpersonali · Inclusione sociale · Diritti
Benessere	Emozionale · Fisico · Materiale

- **Indicatori oggettivi** → standard condivisi (es. piramide alimentare)
- **Indicatori soggettivi** → preferenze, vissuti personali — entrambi necessari
- **Dimensione ecologica (Cottini)** → microsistema (persona) · mesosistema (servizi) · macrosistema (politiche)
- **Ricerca Ticino (Geronimi/SUPSI, 2023)** → QdV buona in generale; domini critici: inclusione sociale e diritti; le variabili **ambientali** pesano più di quelle personali • (Lez. 10)

Progetto di vita • (Lez. 10)

- **Definizione** → progettazione globale che abbraccia tutta la traiettoria di vita
- **Punto di partenza** → desideri, sogni, aspirazioni della persona
- **Co-costruito** con: persona + famiglia + rete di riferimento
- **Non è il PEI/PSI** → li include e li coordina (i PEI/PSI sono tasselli, non devono contraddirsi)
- Deve essere scritto "a matita" (Lepri) → rivalutato e modificato continuamente

Assessment (valutazione iniziale) • (Lez. 10)

- **Scopo** → conoscere i desideri e confrontarli con la situazione attuale
 - **Sguardo ecologico** → persona nel suo contesto (in linea con ICF)
 - **"Modo di essere" di Rogers** → autenticità · accettazione incondizionata · empatia
 - **Rischio da evitare** → *services-led* (valuto in base ai servizi disponibili)
 - **Obiettivo** → *needs-led* (valuto in base ai bisogni reali)
-

Termini e linguaggio rispettoso • (Lez. 05)

- **Regola SUPSI** → persona prima del deficit: "persona con disabilità" (non "disabile" come sostantivo)
 - **Da evitare** → invalido, handicappato, diversamente abile, portatore di handicap
 - **Motivazione** → sostantivare riduce la persona al deficit
-

Autori e riferimenti principali

Chi	Contributo	Lezione
Charles Gardou	<i>Nessuna vita è minuscola</i> (2016); 5 assiomi; "Terza nazione del mondo"	01, 05
Jean-Luc Nancy	Concetto di "singolari plurali"	01
Jürgen Habermas	Agire strumentale vs. comunicativo	01
Philippe Pinel	Trattamento morale; toglie le catene a Bicêtre (1793)	02
Jean-Marc Itard	5 principi pedagogici; Victor dell'Aveyron; padre pedagogia speciale	02
Esquirol	Prima classificazione scientifica: idiozia, imbecillità, demenza (1818)	02

Chi	Contributo	Lezione
Abbé de l'Épée	Prima scuola pubblica per sordi (1760)	02
Valentin Haüy	Prima scuola per ciechi; forma Braille (1784)	02
OMS	ICD, ICIDH (1980), ICF (2001), ICF-CY (2007)	05, 06
Mainardi	4 modelli istituzionali (esclusione, segregazione, integrazione, inclusione)	05
ONU	CDPD — adottata 2006; ratifica CH 2014	04
AAIDD	Definizione DI + sistemi di sostegno (2022)	07
Binet + Simon	Prima scala di intelligenza (1905)	07
Vygotskij	Zona di Sviluppo Prossimale	07
Wood, Bruner, Ross	Scaffolding (1976)	07
Leo Kanner	"Autismo precoce infantile" (1943)	08
Lorna Wing	Triade + concetto di spettro (1983)	08
DSM-5	Diade diagnostica ASD + 3 livelli di gravità (2013)	08
Schopler	TEACCH (1972)	09
Rogers e Dawson	ESDM / Modello Denver	09
Halliday	7 funzioni linguistiche (1975–1980)	09
Schalock e Verdugo	Meta-modello QdV: 3 fattori, 8 domini (2006)	10
Cottini	QdV come macro-finalità e strumento; ecologia (micro/meso/macro)	10

Chi	Contributo	Lezione
Geronimi / SUPSI	Ricerca QdV in Ticino (2023)	10
Pro Infirmis / Fondazione Diamante	Lingua facile in Svizzera e Ticino	04

Parole chiave della materia

disabilità · handicap · deficit · menomazione · inclusione · integrazione · segregazione · esclusione · grande reclusione · trattamento morale · ius vivendi · ICD · ICIDH · ICF · ICF-CY · PPH · modello biomedico · modello biopsicosociale · facilitatore · barriera · capacità · performance · CDPD · "niente su di noi senza di noi" · Lingua Facile · art. 19 · autodeterminazione · QI · comportamento adattivo · scaffolding · ZSP · SIS · deficit intellettuale · disabilità cognitiva · ASD · diade diagnostica · spettro · neurodiversità · sameness · ecolalia · CAA · PECS · ABA · TEACCH · ESDM · PEI · analisi funzionale · parent training · polyhandicap · causalità elementare · QdV · meta-modello · progetto di vita · assessment · needs-led · services-led · microsistema · mesosistema · macrosistema · Atgabbes · Pro Infirmis · LISPI · Fondazione ARES · singolari plurali

Filo conduttore

Il modulo percorre una trasformazione radicale nel modo in cui la società pensa alle persone con disabilità: da oggetti di paura, pietà o curiosità a soggetti di diritto. Questa traiettoria attraversa la storia (dall'infanticidio greco ai pionieri dell'educazione speciale), i modelli teorici (dal biomedico al biopsicosociale), il diritto internazionale (CDPD 2006) e gli strumenti clinico-educativi (ICF, PEI, analisi funzionale). L'arrivo naturale è la qualità di vita: tutto il lavoro educativo e di sostegno non ha senso se non migliora la vita reale della persona, nei suoi otto domini, secondo i suoi standard, non i nostri. L'inclusione non è un traguardo raggiunto — è un **orizzonte** verso cui orientare ogni scelta professionale, sapendo

che la disabilità non abita nella persona, ma nello spazio tra la persona e un contesto che non sa ancora accoglierla.